



**FACULTAD DE EDUCACIÓN INFANTIL
DEPARTAMENTO DOCENTE DE EDUCACIÓN ESPECIAL
CARRERA: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN LOGOPEDIA**

**EJERCICIO DE CULMINACIÓN DE ESTUDIO
EXAMEN ESTATAL
ESTUDIO DE CASO A UN EDUCANDO CON UN RETRASO SIMPLE DEL
LENGUAJE ASOCIADO AL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA**

AUTORA: KARLA IGLESIAS HERNÁNDEZ, 4TO AÑO, PLAN DE ESTUDIO E

**LA HABANA
CURSO ESCOLAR: 2021**

RESUMEN

La realización de esta investigación permitió ampliar los conocimientos y conocer la fundamentación teórica y metodológica del estudio de caso y los trastornos del lenguaje, dando lugar al cumplimiento del objetivo principal de la atención logopédica, corregir y/o compensar el trastorno de la comunicación en el educando. Se presenta la investigación referida al estudio de caso y trastorno del espectro autista, dando lugar a identificar un retraso del lenguaje con la ayuda de métodos teóricos y empíricos y técnicas de investigación que permitieron definir una estrategia de intervención pedagógica y posteriormente un sistema de tratamientos logopédicos. Cada uno de los temas expuestos en esta investigación están relacionados entre sí, tanto en lo teórico como en lo práctico, favoreciendo a un mejor entendimiento por parte de los interesados en esta investigación.

SUMMARY

The carrying out of this research allowed to broaden the knowledge and to know the theoretical and methodological foundation of the case study and language disorders, thus fulfilling the main objective of speech therapy, correcting and / or compensating communication disorders in the student. This paper presents investigation referring to the case study and the autism spectrum disorder, leading to the identification of a language delay with the help of theoretical and empirical methods and research techniques that allowed defining a pedagogical intervention strategy and subsequently a speech treatment system. Each of the topics discussed in this research are related to each other, both theoretically and practically, favoring a better understanding by those involved in this research.

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
DESARROLLO.....	3
Epígrafe 1: Fundamentación teórica y metodológica del estudio de caso a un educando con un retraso simple del lenguaje asociado a un trastorno del espectro autista.....	3
Epígrafe 2: Resultados del estudio de caso. Propuesta de estrategia de atención logopédica.....	20
I Datos generales.....	20
II Motivo de la selección para el estudio de caso.....	20
III Características del entorno familiar.....	20
IV Características del entorno escolar.....	20
V Dinámica del menor seleccionado.....	21
VI Fundamentación de la Estrategia de Evaluación.....	21
VII.-Valoración integral de los resultados de la evaluación psicopedagógica. Precisión de Potencialidades y Necesidades.....	21
IX.- Estrategia de intervención propuesta	24
Sistema de tratamientos.....	25
CONCLUSIONES.....	37
RECOMENDACIONES.....	38

INTRODUCCIÓN

El estudio de caso constituye una fuente de información muy importante para la Educación Especial y la Logopedia. Este método dentro de otros aspectos de interés posee su amplitud, calidad y objetividad de las investigaciones realizadas por cada uno de los especialistas. Un enfoque interdisciplinario y multifactorial en el análisis e interpretación de la información por los diferentes especialistas que intervienen en el estudio; así como la flexibilidad en la valoración de los resultados.

Posee la capacidad para ordenar jerárquicamente la información obtenida, en sus diferentes interrelaciones, mediante la participación de los especialistas que intervinieron en el estudio, maestro y otros profesionales que puedan aportar a la dinámica del análisis. Se caracteriza por la integración de la información, a partir de su adecuada interpretación, posee una riqueza y profundidad del debate y discusión diagnóstica durante la sesión(es) de trabajo.

El estudio de caso no se realiza a todos los educandos, solo aquellos que luego de ser diagnosticado siguen presentando dificultades, siendo necesario un estudio más profundo y completo. Diversos son los autores que se han destacado en el análisis de los fundamentos teóricos y metodológicos relacionados con este método científico, entre otros Andrés J. (1980) y Hartley (1994). En Cuba el estudio de casos es objeto de análisis y valoración por especialistas entre ellos Torres M. (1994); Ortega L. (2001); Gutiérrez E. (2003); Pérez M. (2005) y Nieves M. L. (2007).

Por otra parte, uno de los trastornos más frecuentes a realizar un estudio de caso por la complejidad de los componentes que se ven afectados, es el trastorno del espectro autista (TEA). Constituye un trastorno grave y crónico del desarrollo que afecta, como consecuencia de una disfunción en el sistema nervioso central, las capacidades básicas para la relación social, la comunicación e imaginación.

Un síndrome de la niñez que se caracteriza por falta de relaciones sociales, carencia de habilidades para el intercambio afectivo, reiteración de rituales compulsivos y una resistencia manifiesta al cambio. Un educando con TEA, no se relaciona con las personas que se encuentran a su alrededor, y en cambio prefiere, jugar de forma repetitiva con un objeto, a modo de "fetiche", que puede ser un juguete o no, o con su propio cuerpo.

El lenguaje, si existe, sufre profundos desajustes; aun cuando el educando se halla consciente del medio que lo rodea, de tal modo que, si se interfiere con su actividad lúdica ritual, o si los objetos conocidos en su entorno son cambiados de lugar, él se molesta y comienza con berrinches. Estas manifestaciones comienzan habitualmente en la infancia, algunas veces desde el nacimiento, pero se hace evidente durante los primeros tres años de vida.

Entre los investigadores con valiosos estudios sobre el autismo se destacan Kanner L. (1943); Asperger H. (1944); Jiménez P. (1994); Riviére Á. (1997); Wing L. (1997); Martos J. (1997); Cuxart F. (2002).

Uno de los trastornos más frecuentes es en el nivel lenguaje, tienden a aparecer los retrasos del lenguaje. Estos se caracterizan por la no integración de los mecanismos neurofisiológicos, en la formación de los estereotipos dinámicos indispensables para la elaboración del programa neurolingüístico; que involucran tanto su aspecto expresivo, como impreso.

Existe escases en el vocabulario y dificultades en la expresión oral. El lenguaje oral no aparece en la etapa habitual. Esto requiere que el maestro logopeda, que interactúe con ese tipo de educando, necesite de métodos científicos para profundizar en su diagnóstico. Son numerosos los autores que tratan con los retrasos del lenguaje se destacan, entre otros Peña (2011); Figueredo E. (2000); Pérez E. (2002); Chernousova (2008); X. Rodríguez y M.L. Díaz, (2008).

En el presente trabajo determina como objetivo general: Proponer un sistema de tratamientos logopédicos para un educando con retraso del lenguaje asociado a un trastorno del espectro autista.

DESARROLLO

Epígrafe 1: Fundamentación teórica y metodológica del estudio de caso a un educando con un retraso simple del lenguaje asociado a un trastorno del espectro autista

1.1 El estudio de caso

El método del estudio de casos comienza a utilizarse con más frecuencia en las ciencias humanísticas y sociales como procedimiento de análisis de la realidad objetiva. Según Andrés J. (1980) “el método del caso es esencialmente activo y, por lo tanto, aplicable en innumerables campos donde se trate de combinar eficientemente la teoría y la práctica. Es inaplicable donde sólo se intente la pura erudición o el mero tecnicismo”.

Un caso es la historia de una situación de la vida real que se ha enfrentado por sujetos dentro del contexto ambiental en que se desenvuelven. Incluye no sólo hechos; sino también opiniones y prejuicios que comúnmente rodean y complican su labor. A partir de los hechos que se descubran en el caso, se debe analizar la situación y hacer suposiciones que se adecuen a otros hechos posibles. Detectar el o los problemas que el caso plantea y ofrecer alternativas de solución para, finalmente, decidirse por una.

Como método de acción pedagógica nació en Estados Unidos. Más allá de un método de formación, la metodología del estudio de casos se desarrolla en la investigación educativa. Principalmente en los procesos de evaluación de determinados proyectos pedagógicos y didácticos, de organización y clima social del aula y de pensamiento del profesor, del administrador de la educación o de los propios educandos, entre otros.

En síntesis, no obstante que todavía predomina en la investigación social y educativa la obsesiva preocupación por la medición cuantitativa, el método cualitativo del estudio de casos en la actualidad toma relevancia. Visto esto desde diferentes perspectivas como método de: formación de profesionales, investigación educativa y diagnóstico, terapia y orientación al sujeto o realidad única.

Los autores no se ponen de acuerdo en el año de iniciación y aplicación Ramírez I. (1972) calcula que fue en 1908 y Andrés J. (1980), hacia 1914. De cualquier modo, todos coinciden en que fue en la *Business School* de la Universidad de Harvard en donde se sistematizó y estructuró gracias a *Malvin T. Cipeland*, profesor de derecho

comercial; apoyado por Gray, fundador y rector de dicha Universidad, lo introdujo en la enseñanza del programa de derecho y leyes y también se utilizó como preparación de directivos de empresas.

Desde la Edad Media se utiliza, «el caso», como el ejercicio práctico para resolver problemas morales y religiosos. Generalizándose posteriormente a otros centros educativos de Europa y América como técnica de enseñanza - aprendizaje.

En Cuba el estudio de casos es objeto de análisis y valoración por numerosos especialistas entre ellos Torres M. (1994); Ortega L. (2001); Gutiérrez E. (2003); Pérez M. (2005) y Nieves M. L. (2007). Se destacan los valiosos aportes relacionados con el sistema educacional en cuestiones referentes a sus usos como método de investigación científica, en el proceso de evaluación, diagnóstico y orientación; así como en la concepción de estrategias de intervención para el mejoramiento de la calidad educativa. Según Torres M. (1994): es un proceso de análisis, reflexión y debate que realiza el equipo interdisciplinario que participa en la evaluación y estudio de un sujeto, con el objetivo de explicar las características de su desarrollo evolutivo y los posibles factores causales que han determinados las mismas, para arribar a un diagnóstico desarrollador, que permita una adecuada orientación e intervención, que promueva las transformaciones necesarias para lograr un nivel ascendente en ese desarrollo.

Plantea Hartley (1994)" El estudio de casos es un tipo de investigación social que se caracteriza por la indagación empírica de los problemas de estudio en sus propios contextos naturales, los que son abordados simultáneamente a través de múltiples procedimientos metodológicos".

Refiere Pérez M. (2005): es la representación de una situación de la realidad como base para la reflexión y el aprendizaje, el planteamiento de un caso es siempre una oportunidad de aprendizaje significativo y trascendente en la medida en que quienes participan en su análisis y reflexión logran involucrarse y comprometerse tanto en la discusión del caso como en el proceso de su diagnóstico e intervención.

De forma general, se señalan etapas para realizar un estudio de casos.

Primera etapa: El investigador busca simplemente familiarizarse con la naturaleza y el ámbito del área objeto de estudio. Se orienta al logro de un conocimiento básico del fenómeno, así como a cuestiones fundamentales y problemas implicados en el mismo.

Segunda etapa: supone una continua obtención de datos a través de diferentes medios.

Tercera etapa: hace referencia al análisis de los datos que comienza a recoger e ir haciendo los primeros análisis provisionales de los mismos. El análisis hace alusión a la comprobación de las interferencias producidas por los procesos sociales y educativos que pueden estar implicados, con el fin de coordinar la información. Esto requiere una continua interacción entre la conceptualización y la observación en todas las etapas, más que su superación temporal a lo largo de las mismas.

Los estudios de casos pueden ser: descriptivos, interpretativos y evaluativos.

Estudio de casos descriptivo: presenta un informe detallado de un fenómeno objeto de estudio sin fundamentación teórica previa. Son enteramente descriptivos, no se guían por generalizaciones establecidas o hipotéticas, ni desean formular hipótesis generales. Son útiles, sin embargo, para aportar información básica en ciertas áreas educativas.

Estudio de casos interpretativos: contiene descripciones ricas y completas. Sin embargo, los datos descriptivos los utilizan para desarrollar categorías conceptuales o para ilustrar, defender o refutar presupuestos teóricos defendidos antes de recoger los datos. Si no existiera teoría o si la teoría existente no explica adecuadamente el proceso estudiado.

Estudios de casos evaluativos: implican descripción, explicación y juicio. Proporciona una descripción completa, fundamentada, holística y viva, que simplifica los datos considerados por investigador, esclarece significados y puede comunicar conocimiento tácito. Pero, sobre todo, este tipo de estudio de casos sopesa “la información para emitir un concepto”. La emisión de conceptos es la culminación del proceso de evaluación y su esencia.

Los autores Andrés J. (1980); Hartley (1994), Torres M. (1994), Ortega L. (2001), Gutiérrez E. (2003), Pérez M. (2005) y Nieves M.L. (2007) coinciden en sus definiciones en que el estudio de caso es un método científico de investigación. Transita por un proceso de evaluación, diagnóstico y orientación dando paso a la realización de la estrategia de intervención, combinando la práctica y la teoría.

Por las características que presenta el educando al que se le realiza este estudio de caso la autora asume la definición de la Pérez M. (2005): Es la representación de una situación de la realidad como base para la reflexión y el aprendizaje. El planteamiento

de un caso es siempre una oportunidad de aprendizaje significativo y trascendente en la medida en que quienes participan en su análisis y reflexión, logran involucrarse y comprometerse tanto en la discusión del caso como en el proceso de su diagnóstico e intervención.

De acuerdo con Stake R. (1994) el estudio de caso es una metodología de investigación que se utiliza para conocer un caso en particular. Posee como objetivos:

- recoger, organizar y sintetizar la información sobre el alumno para enriquecer la caracterización del escolar;
- explicar y diagnosticar las características del desarrollo evolutivo del alumno y posibles factores causales implicados en las necesidades educativas especiales que deben ser atendidas a partir del enfoque integral y así diseñar estrategias de atención educativa integral para desarrollar las potencialidades y satisfacer las necesidades educativas especiales;
- contribuir a la superación constante y sistemática del personal docente a partir de las experiencias que se obtengan de cada caso estudiado.

La realización del estudio de casos se rige por determinadas exigencias:

- objetividad y calidad de las evaluaciones realizadas por cada uno de los especialistas;
- enfoque interdisciplinario y multifactorial en el análisis e interpretación de la información;
- flexibilidad en la valoración de los resultados;
- capacidad para ordenar jerárquicamente la información y sus interrelaciones;
- retroalimentación de los especialistas, docentes, padres y otros profesionales que puedan aportar a la dinámica del análisis;
- riqueza y profundidad del debate y discusión diagnóstica durante las sesiones del estudio de casos;
- atención especial en el análisis a la información y criterios contradictorios que surjan en el proceso de la investigación;
- organización de la información por el especialista, quien coordina el estudio de casos.

La metodología utilizada para el estudio de caso en cuestión fue la aportada por Álvarez C. (2002), la cual se presenta a continuación.

I.- Datos Generales: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, edad, grado o nivel escolar, escuela, dirección

II.- Motivo de la selección para el estudio de caso

III.-Características del entorno Familiar

IV.-Características del entorno Escolar

V.- Dinámica del menor (o la menor) seleccionado: antecedentes patológicos familiares y personales, desarrollo psicomotor y físico, características psicopedagógicas, hechos significativos conductuales y de aprendizaje (ver anexo)

VI.-Fundamentación de la Estrategia de Evaluación o sea de los instrumentos o pruebas seleccionados

VII.-Valoración integral de los resultados de la evaluación psicopedagógica. Precisión de Potencialidades y Necesidades

VIII.-Conclusiones (Impresión Diagnóstica)

IX.- Estrategia de intervención propuesta (sistematización de la orientación hacia los diferentes contextos de actuación del caso)

1.2 Trastorno del espectro autista

El término autismo, que significa sí mismo, puede describirse como una retirada por parte del paciente, del mundo social, para sumergirse en sí mismo. Es preferible el uso de este término antes, que otros, como autismo infantil, que puede sugerir la idea errónea de que este trastorno solo se presenta en la infancia. El autismo no es un fenómeno moderno, aun cuando solo se haya reconocido en tiempos modernos, se describen casos desde el siglo XIX.

Antes de los tres años, deben producirse retrasos o alteraciones en una de estas tres áreas: interacción social, empleo comunicativo del lenguaje o juego simbólico. Si bien en las primeras descripciones de autismo que hizo Kanner en 1943, ya se hacía énfasis en estos tres aspectos; las ideas sobre el autismo han recorrido un largo y tortuoso camino hasta alcanzar los conceptos actuales.

Otra brillante intuición de Kanner fue considerar que estos educandos tenían algún defecto innato que era responsable de su conducta. Así mismo, también afirmó, que el

autismo era un síndrome distinto de las otras enfermedades psiquiátricas de la época. Sin embargo, en tiempos de euforia psicoanalítica, hacia finales de la década de los 40, lanzó la idea de que era una forma de esquizofrenia y cuyo origen debía buscarse en la influencia de padres fríos, incapaces de proporcionar el afecto necesario.

Estas teorías no estaban sustentadas por ningún trabajo de investigación. Tampoco se tomó en consideración la posibilidad alternativa de que la prevalencia de padres fríos podía representar un dato relacionado con la transmisión genética del trastorno. La idea de padres culpables, fue tomando fuerza durante los años 50 y 60.

Se intentaba descifrar el enigma psicogenético que en cada situación había trastornado la mente hasta el punto de recluirla en un cosmos impenetrable. Se fue también extendiendo la denominación de autismo como psicosis infantil, sobre la base de la supuesta relación con la esquizofrenia.

Esta dificultad se inicia con su diagnóstico, en donde se utilizan muchos nombres para tipificar a un mismo problema, sin embargo, son diversas las causas que desencadenan esta condición. La definición de autismo, evoluciona a través del tiempo, desde Kanner (1943) quien fue la primera persona en dar una caracterización precisa, la cual, se ha ido enriqueciendo por las múltiples investigaciones que se han realizado y que han permitido el desarrollo de un cuadro clínico más completo y comprensivo (Tinbergen, 1972; Lovaas, 1965; Polaino-Lorente, 1982; Hobson, 1995).

El “Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales” de la Asociación Americana de Psiquiatría (1995) lo define como: Un trastorno generalizado del desarrollo que se caracteriza por una perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo: habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación o presencia de comportamientos intereses y actividades estereotipadas. Las características esenciales del trastorno autista son la presencia de un desarrollo marcadamente anormal o deficiente de la interacción y comunicación y un repertorio sumamente restringido de actividades e intereses. (APA, DSM IV, p. 69).

Actualmente no se puede aceptar la base psicológica del autismo, ante la sólida evidencia de su base orgánica, proporcionada por los estudios genéticos (Bolton P, McDonald H, Pickles A et al, 1994) (Le Couteur A, 1996), neurofisiológicos (Plioplys A.V., 1994), neuropatológicos (Courchesne E.; Townsend J. y Saitoh O.(1994)

neurorradiológicos (Piven J, Arndt S, Bailey J et al, 1995) y bioquímicos (Cook EHJ, Courchesne R, Lord C, et al , 1997)

Dentro de las particularidades específicas de estas personas y que tienden a generar confusión en quienes interactúan con ellas están: un desarrollo anormal de la interacción y la comunicación social, que afecta la capacidad natural para desarrollar habilidades de interacción social. Iniciar conversaciones, relacionarse adecuadamente, y esto se interpreta y mitifica como que no quieren hacerlo.

Aunado a lo anterior, la presencia de comportamientos inusuales, estereotipados y repetitivos, además de conductas ritualistas y rutinarias, son elementos que se suman para generar creencias irracionales sobre su etiología y posibles tratamientos a utilizar, los cuales difícilmente son efectivos. Los movimientos corporales estereotipados incluyen las manos (aletear, dar golpecitos con un dedo) o todo el cuerpo (balancearse, inclinarse, mecerse). Pueden estar presentes anomalías posturales (ejemplo caminar de puntillas, y movimientos manuales y posturas corporales extravagantes). (APA, DSM IV, p. 71).

Conforme se profundiza en el estudio de este síndrome a nivel neurológico y bioquímico. Se determina la presencia de algunos neurotransmisores en cantidades mayores o menores de lo normal, como es el caso de la serotonina, que es un “neurotransmisor cerebral que está implicado en numerosas funciones mentales como el comportamiento, el sueño, la agresividad, la ansiedad y la regulación afectiva” (Morant, 2003). Con base en estos estudios y otros realizados en áreas diferentes a la neurobioquímica, podría darse una explicación lógica de las conductas que presentan estos educandos y aclarar científicamente el por qué algunas de las creencias de los padres y profesionales.

Son muchos los esfuerzos realizados para dar una explicación válida y confiable acerca de lo que es el autismo, pero, todavía esa meta no se ha logrado a cabalidad, por lo complejo de sus posibles etiologías.

Entre los investigadores con valiosos estudios sobre el autismo se destacan Kanner L. (1943), Asperger H. (1944), Jiménez P. (1994), Rivière Á. (1997), Wing L. (1997), Martos J. (1997), Cuxart F. (2002), los cuales coinciden en que es trastorno del

espectro autista (TEA) se caracteriza por alteraciones en la comunicación comportamientos estereotipados u obsesivos o alteraciones en la interacción social.

Por las características del educando con que se está trabajando la autora asume la definición del “Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales” de la Asociación Americana de Psiquiatría (1995) que lo define como: Un trastorno generalizado del desarrollo que se caracteriza por una perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo: habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación o presencia de comportamientos intereses y actividades estereotipadas.

Cuando se hace referencia al TEA, se precisan un conjunto de trastornos en el que coexisten tres grupos de manifestaciones.

1. Trastorno de la relación social.
2. Trastorno de la comunicación, incluyendo comprensión del lenguaje y capacidad de expresión.
3. Falta de flexibilidad mental, que condiciona un espectro restringido de conductas y una limitación en las actividades que requieren cierto grado de imaginación.

Presentan comportamientos que en ocasiones son difíciles de comprender. Pueden ser alteraciones en la comunicación (mutismo, ecolalia o habla literal); comportamientos estereotipados u obsesivos (girar objetos, balancearse, aleteo, conductas repetitivas) o alteraciones en la interacción social.

En Cuba se contribuye al perfeccionamiento de la labor que se realiza con estos educandos desde la escuela y la familia en estudios desarrollados por Escalona E. (1997); Campos I., Demósthene Y. (1998, 1999, 2003); Barbosa V. (2000); Gómez I. (2005) entre otros, en importantes áreas como: el lenguaje y la comunicación, la conducta social, la intervención de las familias y comunidad en la socialización.

La responsabilidad del estado cubano y en particular de las familias como agencia educativa se expresa en documentos oficiales y legislaciones estatales vigentes. La Constitución de la República de Cuba en su artículo 40 regula que: “Las familias (...) tienen el deber de prestar especial atención a la formación integral de la niñez y la juventud” y en su artículo 42 establece que “la discriminación por motivo de razas, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la

dignidad humana está proscrita y es sancionada por la ley” , lo que demuestra la prioridad que se le concede a las familias en la educación de su descendencia y el respeto al hombre.

En otros documentos programáticos aprobados en Cuba como el Código de la Niñez y la Juventud, proclamado en 1976, se regula en su artículo 4 que “... la sociedad y el estado reconocen el papel y la autoridad de las familias en la formación (...) de sus miembros más jóvenes.

Las familias tienen la obligación (...) de conducir el desarrollo integral de los educandos y jóvenes y estimular en el hogar el ejercicio de sus deberes y sus derechos. La elevación del nivel (...) cultural (...) de la familia, como resultado del desarrollo de la revolución y la asistencia que recibe de los organismos correspondientes del Estado favorece (...) la realización de esta labor...”, lo que ratifica la coherencia en la proyección humanista de un tipo de sociedad que coloca al ser humano en el centro de su quehacer.

Las características esenciales de los educandos con TEA son la presencia de un desarrollo marcadamente anormal o deficiente de la interacción y comunicación y un repertorio sumamente restringido de actividades e intereses. (APA, DSM IV, p. 69).

1.3 Retraso del lenguaje

La escuela tiene el encargo de favorecer el proceso de formación de los educandos a partir de las exigencias culturales y los niveles de desarrollo que estos hayan alcanzado. Sin embargo, todos los educandos no aprenden igual y algunos presentan dificultades para aprender, por lo que precisan una atención diferente.

Unos de los problemas que se identifican con más frecuencia son los relacionados con el desarrollo del lenguaje. Estos en múltiples ocasiones se presentan asociadas a otras necesidades educativas especiales o pueden generarlas.

La atención educativa a los educandos que clasifican con problemas de lenguaje y tienen necesidades educativas especiales se convierte en los últimos años en centro de debate acerca de cuál deberá ser el procedimiento a seguir. El lenguaje como función psíquica superior surge con la propia existencia de la humanidad y se establece en elemento esencial de las relaciones sociales.

Diferentes autores como Peña (2011); Figueredo E. (2000); Pérez E. (2002); y Chernousova (2008), coinciden en destacar que el lenguaje constituye la envoltura material del pensamiento; constituye el principal medio para la comunicación humana que se realiza a través de un sistema funcional complejo, en el que se emplean símbolos específicos principalmente verbales y orales.

Disimiles son los autores que en el ámbito nacional e internacional se han referido al retraso del lenguaje, tales como Peña (2011); Figueredo E. (2000); Pérez E. (2002); y Chernousova (2008), Rodríguez X. y Díaz M.L. (2008) refieren que el retraso del lenguaje, es un trastorno asociado a una limitación del desarrollo del vocabulario y la expresión oral.

Atendiendo a las características del educando en cuestión se asume la definición de retraso del lenguaje dada por Rodríguez X. y Díaz M.L. (2008) que entiende el retraso del lenguaje como “[...] trastorno del lenguaje que afecta la formación y desarrollo de sus componentes estructurales (fonología, semántica, sintaxis) relacionados con los mecanismos de recepción y programación lingüística”, ya que es la más acorde está a las características del educando al que se realiza el estudio de caso.

Se reconoce que el lenguaje es vital para la formación, funcionamiento y regulación de la personalidad, favorece el desarrollo individual depende de la relación entre las condiciones biológicas y el contexto social. La utilización del lenguaje como vía fundamental del educando para comunicarse es un proceso mediado por la participación del adulto pues, la estimulación e integración del sistema de funciones psíquicas le permite al educando tener acceso a la cultura humana y a la comunicación. El lenguaje lo integran tres componentes: fónico (pronunciación), léxico (vocabulario) y gramatical (morfología y sintaxis) estrechamente relacionados entre sí y con la evolución física y psíquica. Según la realización del lenguaje se distinguen dos procesos, la percepción o comprensión del habla (lenguaje impresivo) y su reproducción o realización (lenguaje expresivo), cuya formación depende de las condiciones anatomofisiológicas individuales y las relaciones interpersonales. De esta interrelación emergen mecanismos del sistema funcional verbal y generación del enunciado que instituyen en el lenguaje como función psíquica.

El desarrollo del lenguaje se inicia antes del nacimiento e incorpora a la familia y todos los agentes educativos del contexto social. Sin embargo, las fallas en el proceso de estimulación y aprendizaje desde edades tempranas, generan dificultades que pueden estar asociadas o no a otras necesidades educativas especiales.

Los trastornos del lenguaje han estado presentes en el ser humano desde la antigüedad. Fue la sensibilización social e institucional hacia este tipo de trastornos lo que impulsó a su atención y tratamiento especializado y abrió las posibilidades para enfocar la orientación hacia esta problemática. Fue así que surge la instrucción sistemática de las personas con problemas de lenguaje.

En general, las metodologías se apoyan en un método integral y natural de la enseñanza lengua oral mediante un método basado en signos. Al mismo tiempo se propicia la utilización de aparatos mecánicos, la intervención con técnicas quirúrgicas, de ejercicios de habla y de respiración, esto llevó a que, a inicios del siglo XIX, se aplicaran metodología de atención individualizada; de terapia de control de la respiración y el uso de un sistema de códigos para actuar sobre las cuerdas vocales.

Los trastornos del lenguaje en los educandos impulsaron a que, a principios del siglo XX, se obtuviera la atención pedagógica y llega a promover iniciativas centradas tanto, con la creación de centros especiales como desplegaron iniciativas de integración escolar como en los sistemas de educación pública. En este marco se proporciona un gran impulso en la actividad de logopedia, la cual, desde su incorporación y generalización en los sistemas educativos evoluciona desde un modelo clínico a un modelo escolar, caracterizado por tener que dar una respuesta educativa lo más ajustada posible a las necesidades de cada educando desde el propio ámbito escolar.

De acuerdo con lo anterior, se entiende que promover el desarrollo y atender a dificultades del lenguaje se asume como un reto educativo en la que adquiere importancia las influencias en la esfera psicológica, del aprendizaje y las relaciones sociales. Por tanto, para estimular el desarrollo del lenguaje en el educando, es necesario partir del diagnóstico, caracterizar la dirección del proceso educativo y diseñar alternativas metodológicas que se ajusten a las condiciones y características de las dificultades que en cada caso tiene lugar.

Desde el punto de vista didáctico, y a los fines pedagógicos de la atención logopédica se distinguen tres niveles de la comunicación oral, en los cuales se agrupan los principales trastornos que pueden afectarlos:

Niveles de la comunicación oral:

Lenguaje: Retrasos del lenguaje, Disfasia, Afasia

Habla: Dislalia, Disartria, Rinolalia, Tartamudez, Tartaleo

Voz: Afonías, Disfonías, Tonopatías, Rinofonías

Los trastornos del nivel comunicativo lenguaje se definen como las alteraciones que resultan de la no integración, o desintegración de los mecanismos neurofisiológicos responsables de la formación de los estereotipos dinámicos imprescindibles para la elaboración del programa neurolingüístico; involucran tanto su aspecto expresivo, como impresivo. Se producen por causas orgánicas y funcionales.

La afectación de los componentes estructurales del lenguaje (fonológico, léxico-semántico, morfosintáctico y pragmático) puede variar en dependencia de sus orígenes y carácter, desde una jerga inentendible, hasta una manifiesta fragilidad en los componentes lingüísticos que no se corresponden con la edad del sujeto en cuestión. Estas alteraciones pueden tener un carácter primario (funcionales) o secundario (asociadas a otras características especiales del desarrollo).

Dentro de los trastornos del nivel comunicativo lenguaje se determinan como entidades nosológicas o diagnósticas con carácter primario los retrasos del lenguaje.

“[...] trastorno del lenguaje que afecta la formación y desarrollo de sus componentes estructurales (fonología, semántica, sintaxis) relacionados con los mecanismos de recepción y programación lingüística” X. Rodríguez y M.L. Díaz, (2008).

Los componentes del lenguaje se clasifican según el nivel de gravedad en tres niveles. Un primer nivel en el que se agrupan los educandos que presentan una ausencia total o casi total de herramientas lingüísticas para comunicarse, lo hacen utilizando, generalmente, de manera combinada la mímica, los sonidos onomatopéyicos y una jerga poco entendible.

Un segundo nivel en el cual los educandos presentan un mayor desarrollo de los medios lingüísticos, aunque todavía se aprecian serias limitaciones en la comunicación oral por una considerable reducción del vocabulario que afectaba tanto la expresión

como la comprensión del lenguaje; el componente fonológico se presenta insuficientemente desarrollado, manifestándose no solo en la cantidad de sonidos alterados sino en la estructura sonora silábica de las palabras; el componente gramatical exhibe un atraso significativo en su desarrollo.

El tercer nivel que es el menos severo y de mayor desarrollo comunicativo oral, se presenta con algunas insuficiencias en todos los componentes, en lo fonológico se aprecian errores en la pronunciación de fonemas complejos como la vibrante /r/ en todas sus posiciones y las sílabas directas dobles. La diferenciación de fonemas parecidos acústicamente resulta compleja y gramaticalmente se producen incorrecciones para conjugar algunos verbos y elaborar oraciones compuestas.

Existen etiologías del retraso del lenguaje, las cuales son causas endógenas (predisposición orgánica) que se caracterizan por el déficit auditivo, retraso mental, parálisis cerebral, lesión focal o inmadurez neurológica. Las causas exógenas que estas se caracterizan por tener un ambiente verbal desfavorable, dificultades en las relaciones afectivas padre-hijo, bilingüismo mal empleado, sobreprotección, negativismo, institucionalismo prolongado y uso inadecuado de las tecnologías.

Actualmente en Cuba la atención logopédica a los retrasos del lenguaje se orienta en la utilización de dos formas fundamentales de denominación o diagnóstico: Retraso Específico Severo (RESL) y Retraso Simple del Lenguaje (RSL). Este trastorno presenta tres niveles de gravedad en los retrasos del lenguaje.

En el retraso grave del lenguaje los educandos tienen reducidos sus patrones fonológicos casi al mínimo y se da la dislalia múltiple. El área del significado es pequeña en cantidad y calidad. Su sintaxis se parece a la de etapas muy primitivas (holofrases, habla telegráfica). En la pragmática se percibe una conversación centrada en sí mismo. En estos educandos es necesario realizar un diagnóstico diferencial respecto al retraso intelectual ligero, síndrome de inatención y sobre todo de la disfasia o Trastorno Específico del Lenguaje (TEL).

En el retraso moderado del lenguaje, la reducción de patrones fonológicos es más evidente. Semánticamente, la pobreza de vocabulario expresivo es ya notoria, nombran los objetos familiares, pero desconocen el nombre de muchos otros objetos y conceptos conocidos por los educandos de su edad. Desde el punto de vista morfosintáctico,

están presentes los signos que determinan funciones semánticas primarias: interrogación, negación, etc. Es en los signos que determinan funciones semánticas secundarias de categoría nominal (género y número) y verbal donde se manifiestan claros déficit. Las funciones del lenguaje se actualizan lingüísticamente de manera pobre, con abundantes imperativos y gestos verbales de llamada de atención.

En el retraso leve del lenguaje lo que más llama la atención son las inconstancias en la realización fonológica, un fonema puede ser sustituido por otras producciones fonéticas que tengan parecido acústico-articulatorio. Desde el punto de vista semántico, la actualización lingüística de contenidos cognitivos es ligeramente más escasa que en los educandos sin retraso simple. No obstante, su comprensión parece normal. Su desarrollo morfosintáctico se encuentra en un nivel normal y desde el punto de vista pragmático no se advierten distorsiones ni dificultades especiales.

En el retraso específico severo del lenguaje, considerada la manifestación más grave de presentación del trastorno, los educandos muestran una considerable reducción de los patrones fonológicos, pudiera decirse que se encuentran en “estado embrionario” y consecuentemente se afectan casi todos los sonidos del idioma. Se acompaña además de un significativo retraso, demora, en el desarrollo del vocabulario que se reduce a un pequeño grupo de palabras mal estructuradas desde el punto de vista silábico, con valor poli semántico, en ocasiones inentendibles fuera del contexto en que son utilizadas y sonidos onomatopéyicos. Por lo general esta manera de expresión se acompaña de un lenguaje extra verbal compuesto por gestos, señas y mímica.

La comprensión del lenguaje, aunque tiene un mejor comportamiento también está afectada. Las limitaciones que poseen los educandos en su lenguaje expresivo interfieren la comprensión desde el punto de vista semántico y gramatical del lenguaje ajeno; se manifiesta en la incomprensión de secuencia de órdenes o las que no se relacionan con la situación comunicativa que se desarrolla.

En este tipo de retraso están ubicados los educandos que presentan una severa afectación de todos los componentes del lenguaje y su comportamiento lingüístico comunicativo se corresponde con el que alcanzan los educandos en las primeras etapas de su evolución ontogenética. El establecimiento de una posible línea divisoria entre este tipo de retraso y el simple es algo complejo.

No puede decirse que está marcado por factores subjetivos, pero el especialista debe poseer total dominio sobre los logros del desarrollo en cada periodo evolutivo y evaluar desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo su comportamiento. No obstante, debe quedar claro para los maestros logopedas que en el retraso específico severo del lenguaje hay una ausencia total o casi total de comunicación empleando el lenguaje articulado, en su lugar se utiliza la mímica, la jerga y los sonidos onomatopéyicos.

El retraso simple del lenguaje es la forma menos grosera de presentación del trastorno. La afectación de los componentes fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático refleja un sustancial desbalance si se compara con el desarrollo de otros educandos en igual período evolutivo. Tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo los componentes del lenguaje manifiestan un evidente retardo en cuanto a su evolución.

Algunas de las características generales que presenta es el retraso en la aparición o en el desarrollo de todos los niveles del lenguaje (fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático) que afecta sobre todo a la expresión y en menor medida a la comprensión; como se señala con anterioridad sin que esto se deba a un Retraso Generalizado del Desarrollo (Autismo), ni a déficit auditivo o trastornos neurológicos y la aparición tardía del lenguaje y la expresión, desarrollándose lentamente y de forma desfasada.

Algunas características particulares que presenta este trastorno en el nivel fonológico es que suelen presentar patrones desviados, habla infantilizada, con omisión de consonantes iniciales y sílabas iniciales. En el nivel semántico el vocabulario es reducido a objetos del entorno, presentan problemas en la adquisición de conceptos abstractos, en el nivel morfosintáctico tienen un desorden en la secuencia normal de la oración y el lenguaje es telegráfico, presentan dificultad en la utilización de frases subordinadas, estas suelen ser coordinadas con la partícula/ y/.

En el nivel pragmático presentan dificultades para adaptarse al interlocutor. Se advierten dificultades para repetir y recordar enunciados, apenas utilizan el lenguaje en la función lúdica o imaginativa, presentan dificultades en la comprensión de ordenes sencillas o más complejas en dependencia de la envergadura del trastorno.

Son muchas las causas que provocan el retraso simple del lenguaje, las cuales pueden tener varios orígenes. Entre estos están los hereditarios, socioculturales que se pueden presentar en el modelo familiar que tenga el educando, los factores afectivos que se

evidencian en la sobreprotección de algunas madres que le crean al educando sentimientos de minusvalía y desajustes emocionales. Otro origen son los conflictos en la familia, ya que esta juega un papel importante en el desarrollo del lenguaje.

El retraso simple del lenguaje se clasifica como leve cuando es menor a tres meses de lo esperado para su edad. Lo que llama la atención son distintas formas de facilitación fonológica. Desde el punto de vista semántico, la actualización lingüística de contenidos cognitivos es ligeramente más escasa que en los educandos sin retraso simple.

Es moderado cuando es de tres a seis meses menor de lo esperado para su edad. La reducción de patrones fonológicos es más evidente, semánticamente, la pobreza de vocabulario expresivo es ya notoria. Desde el punto de vista morfosintáctico están presentes los signos que determinan funciones semánticas primarias. Las funciones del lenguaje se actualizan lingüísticamente de manera pobre, con abundantes imperativos y gestos verbales de llamada de atención.

Cuando el trastorno se clasifica de severo es mayor de nueve meses. En el retraso grave del lenguaje, los educandos tienen reducidos sus patrones fonológicos casi al mínimo y se da la dislalia múltiple. El área del significado es pequeña en cantidad y calidad, su sintaxis se parece a la de etapas muy primitivas.

La estrategia de intervención logopédica general para educandos con retraso del lenguaje consta de tres etapas.

1 era Etapa propedéutica o preparatoria

Tiene como **objetivo** la preparación de las condiciones anatomofisiológicas y psicológicas necesarias en los educandos para el aprendizaje del lenguaje oral.

Acciones:

Creación de situaciones comunicativas que motiven la necesidad y el interés de los educandos por comprender y expresar mensajes utilizando el lenguaje extra verbal y verbal.

Ejercitación de la respiración en función del habla.

Ejercitación de los órganos fono articulatorios.

Estimulación de la atención auditiva.

2 da Etapa reproductiva situacional

Tiene como **objetivo** estimular la comprensión y producción de mensajes a partir del empleo gradual de las palabras como expresión del uso funcional del lenguaje.

Acciones:

Ejercitación de los órganos respiratorios y fono articulatorios en la producción de sonidos articulados.

Creación de situaciones comunicativas que demanden la comprensión y producción de palabras para denominar objetos y fenómenos, describir y narrar con frases sencillas.

Instauración, automatización y diferenciación de los sonidos del idioma.

3 era Etapa productiva contextual

Tiene como objetivo la estimulación de la comprensión y producción de mensajes combinando los recursos verbales y extra verbales en diferentes contextos de socialización.

3.1. Enriquecer el vocabulario (presentación, precisión y activación).

3.2. Perfeccionar el componente gramatical del lenguaje.

3.3. Instauración, automatización y diferenciación de los sonidos del idioma.

Epígrafe 2: Resultados del estudio de caso. Propuesta de estrategia de atención logopédica

I - Datos Generales

Nombre y Apellidos: CIGG

F.N: 30 de mayo del 2009

Edad: 11 años

Grado o nivel escolar: 6to grado

Escuela: Lazo de la Vega

II.- Motivo de la Selección para el estudio de caso

Menor que presenta dificultades en la expresión oral, por lo que la maestra y la familia acuden al logopeda.

III.-Características del entorno familiar

La menor convive con su abuela, padrastro y mama, mantiene una buena relación en el hogar, pero no una buena relación en la comunidad ya que no sale de su casa a jugar por su condición. La mamá refiere que la ayuda con las tareas del hogar perfectamente, sabe barrer, limpiar, fregar, cortar cebollas, se prepara la leche y las cosas de comer, se sabe bañar, aunque no le gusta mucho, la madre debe hacerlo por ella porque es un poco vaga, la menor presenta una buena imagen personal.

La familia acepta en trastorno que la niña presenta de manera adecuada y conoce muy bien las deficiencias de la menor. La familia colabora con las actividades de la escuela, mantiene buena relación con el centro y se mantiene comunicada telefónicamente en este tiempo de pandemia, es una familia potenciadora del desarrollo.

IV.-Características del entorno escolar

La menor en ocasiones se muestra indiferente ante sus compañeros, aunque es flexible ante las órdenes de los maestros, refleja afecto ante estos, saluda de forma espontánea. Tiene buena conducta y utiliza el lenguaje expresivo. Para la realización de las actividades es motivada utilizando hasta un tercer nivel de ayuda de forma ocasional en las actividades no planificadas.

Su memoria es a largo plazo con capacidad intersubjetiva y mentalista, al igual que en la conciencia explícita, identifica emociones, comprende acciones y comentarios, su percepción es pobre, se desconcentra fácilmente. Sus actividades preferidas son todas las relacionadas con las manualidades, el canto, es muy artística. Distorsiona la /r/ y la /rr/ en la posición media de manera inconstante.

V.- Dinámica del menor (o la menor) seleccionado

La madre de la menor refiere que su padre falleció de una insuficiencia renal, que estuvo nueve años en hemodiálisis. La menor presenta un buen desarrollo motor, no necesita niveles de ayuda en ese aspecto

VI.-Fundamentación de la estrategia de evaluación

Para la realización de este estudio de caso se emplearon métodos de investigación teóricos y empíricos, procedimientos y técnicas

Se realizó la observación de los modos de actuación de la menor en el centro que permitió conocer su desenvolvimiento en el entorno escolar, ver las dificultades que presentaba en las actividades diarias y la forma de relacionarse con sus coetáneos.

Se realizó entrevista a la familia y a la maestra de la estudiante con el objetivo de indagar y conocer aspectos del entorno escolar y familiar.

Se realizó un análisis documental para conocer las características de la educando.

Se realizó la técnica de exploración logopédica a la educando con el objetivo de diagnosticar el trastorno del lenguaje que presenta.

Se realizó la técnica del dibujo libre a la menor con el objetivo de conocer las habilidades motrices y sensibilidad artística.

VII.-Valoración integral de los resultados de la evaluación psicopedagógica. Precisión de potencialidades y necesidades.

La menor tiene buena puntualidad y a la llegada al centro se muestra con una buena actitud, dispuesta a realizar sus actividades y se ve muy cooperadora. No se relaciona mucho con sus compañeros, en cambio sí con todos los maestros.

No juega con sus compañeros. Sabe comer sola y mantiene buena limpieza durante la merienda y el almuerzo.

En las actividades se muestra un poco intranquila, aunque si se le motiva adecuadamente se concentra, le gusta mucho las actividades de manualidades, pegar, recortar y cantar, todo lo que tenga que ver con el arte. Presenta dificultades en las actividades que se relacionan con leer y escribir, por lo que distorsiona la /r/ y la/ rr/ en la posición media de forma inconstante.

Centro: Escuela especial Lazo de la Vega
--

Nombres y apellidos: CIGG					Expediente CDO										
Fecha de nacimiento 30 de mayo del 2009			Edad 11		Sexo F		Grado 6to		Cursos de repitencia						
Procedencia del educando Escuela especial Cheche Alfonso															
Motivo de consulta Exploración del lenguaje															
Datos concretos sobre la evolución del lenguaje Sus primeras palabras fueron a los dos años y ocho meses, fue atendida x la logopeda desde el primer año de nacida.															
Otros datos de interés El educando presenta un trastorno del espectro autista.															
Examen específico del habla. Estado del aparato articulatorio Labios: normales Dientes: buena dentadura Lengua: tiene movilidad hacia las CUATRO direcciones Paladar: normal Velo: normal															
Características de la audición Impresiona normal. Responde a su nombre, conoce algunos sonidos onomatopéyicos. Responde a la voz cuchicheada a diferentes distancias.															
Estado de la expresión oral. Conversación espontánea. Características Responde ante situaciones problemáticas de manera correcta. Logra narrar con niveles de ayuda a pesar de que presenta dificultades. No logra describir una lámina en su totalidad. Relata a través de frases sencillas. No es muy expresiva.															
Vocabulario (volumen, calidad, significado) Vocabulario amplio. Conoce el significado de algunas cosas. Comprende bien las cosas que se le dicen. Responde ante el vocabulario por imágenes. Conoce algunas acciones y las nombra. Nombra todos los objetos.															
Estructura gramatical (análisis de las características morfológicas) Conoce el significado de las cosas y emplea sustantivos, adjetivos y verbos.															
Análisis de la pronunciación y de los procesos fonemáticos															
fonema	I	M	F	fonema	I	M	F	fonema	I	M	F	fonema	I	M	F
a				K				FL				ei			
e				G				GL				eu			
o				J				CL				oi			
i				T				BR				ou			
u				D				PR				ia			
m				N				FR				ie			
p				S				DR				iu			
b				L				TR				io			
f				R		x		GR				ua			
ch				Rr		x		CR				ue			
y				BL				ai				ui			
ñ				PL				au				uo			

Observaciones
Distorsión de la r y la rr en la posición media de forma inconstante.
Ritmo y fluidez del Lenguaje
Se expresa de manera normal, no presenta ningún tipo de vacilaciones, ni titubeos. No presenta espasmos.
Características de la voz
El tono de la voz es medio y no presenta cambios bruscos durante la fonación. Presenta un timbre sonoro y una intensidad normal. Presenta una respiración clavicular.
Examen de la lectura y escritura
Lee y escribe las vocales de forma correcta a través del dictado. Logra escribir, pero con faltas de ortografías.
Escritura
Hay presencia de macrografía. No mantiene las letras dentro del renglón.
Conducta observada durante la prueba
Tiene contacto ocular, acepta el contacto físico con adultos y sus coetáneos. Se mostró durante la prueba colaboradora, aunque se distrae con facilidad, cuando la actividad no le gusta forma perreta, aunque en ocasiones se concentra.

Para realizar las actividades en ocasiones necesita hasta un tercer nivel de ayuda, no siendo así si es bien motivada y si la actividad le interesa. Realiza las tareas rápidamente y con buena calidad.

Se muestra flexible ante las órdenes que recibe y tiene buena conducta comunicativa, clara y legible, utiliza un lenguaje expresivo de forma oracional con una entonación característica del trastorno del espectro autista. Su memoria es a largo plazo y resuelve problemas de la mente de primer orden, su percepción es pobre y su atención en ocasiones es dispersa.

La familia es potenciadora del desarrollo, su mamá se muestra muy preocupada y no falta a las reuniones de padres, mantiene contacto telefónico con la maestra, es muy servicial ante la escuela.

VIII.-Conclusiones (Impresión Diagnóstica)

Diagnóstico logopédico

La menor CIGG de once años que cursa en la escuela especial Lazo de la Vega presenta un trastorno de la comunicación en el nivel lenguaje, enmarcado en un retraso simple del lenguaje asociado a un trastorno del espectro autista. Menor que responde ante las situaciones problemáticas de forma correcta.

Conoce los sonidos onomatopéyicos. Presenta un vocabulario amplio, lee y escribe las vocales. Reconoce y nombra el significado de los objetos. Le gusta el dibujo y el canto,

se muestra colaboradora cuando se motiva sus necesidades. Logra narrar, pero necesita hasta un tercer nivel de ayuda.

No logra describir una lámina si no es con ayuda. Es poco expresiva. En su escritura hay presencia de macrografía. Su respiración es clavicular. Distorsiona el fonema /r/ y la sílaba directa doble /rr/ en la posición media de manera inconstante.

Potencialidades

Conoce los sonidos onomatopéyicos.

Responde ante situaciones problemáticas de manera correcta.

Narra con niveles de ayuda.

Presenta un vocabulario amplio.

Reconoce y nombra el significado de los objetos.

Lee y escribes las vocales.

Se muestra colaboradora

Le gusta el dibujo y el canto

Necesidades

Presenta dificultades para narrar, necesita niveles de ayuda.

No logra describir una lámina en su totalidad.

No es muy expresiva.

Distorsiona la /r/ y la /rr/ en la posición media de forma inconstante.

Presenta una respiración clavicular.

Hay presencia de macrografía.

IX.- Estrategia de intervención propuesta. (Sistematización de la orientación hacia los diferentes contextos de actuación del caso).

Objetivo: Estimular la comunicación oral y el lenguaje expresivo y receptivo.

Tareas

Estimulación de la comunicación espontánea a través de diferentes situaciones.

Incremento del vocabulario activo y pasivo mediante láminas, tarjetas y asociación de objetos reales.

Realización de los ejercicios pre articulatorios en cada tratamiento para desarrollar la movilidad articulatoria.

Ejercitación de las habilidades de lectura y escritura.

Desarrollo de la habilidad de comprensión y la orientación espacial.

Orientación a la familia y al maestro del aula.

Exploración del lenguaje

Sistema de tratamientos logopédicos

La concepción dialéctica materialista del mundo permite ver al ser humano desde una visión holística formado y desarrollado históricamente y socialmente, por lo antes expresado se considera una premisa fundamental para comprender las relaciones sociales. El vínculo de los principios, leyes y categorías filosóficas permite establecer relaciones del fenómeno objeto de estudio. Gracias al análisis objetivo subjetivo de la problemática se pudo hacer un diagnóstico explicativo con carácter sistémico, conocer el origen y las causas de la situación existente en el lenguaje de la menor, favoreciendo a la identificación de una estrategia de intervención pedagógica y posteriormente a la realización de un sistema de tratamientos logopédicos.

La Dr. C Morales, M. en su libro Enfoque práctico de la Logopedia, define la atención logopédica como un “sistema de acciones o tareas basadas en el diagnóstico logopédico que tiene un carácter psicopedagógico y están dirigidas a la prevención, atención, evaluación e investigación científica de la comunicación humana y sus trastornos”

El tratamiento logopédico es similar a una clase por su estructura didáctica, en el debemos lograr la salida coherente de hábitos de educación formal, contenidos políticos, educación socio moral, tratamiento al programa director de valores, según lo propicie el eje temático a desarrollar. En un tratamiento logopédico debe existir variedad de elementos que se deben tener en cuenta según las distintas logopatías, pues en cada una hay que priorizar elementos en correspondencia con los síntomas que la caracterizan.

“Constituye una actividad pedagógica especialmente dirigida al desarrollo de la comunicación y el lenguaje, con fines preventivos, en la que se emplean recursos metodológicos para la corrección y/o compensación del lenguaje oral y escrito, de forma individual, en pareja y/ o grupal. En ella se satisfacen las demandas educativas de los

escolares para el empleo de un habla inteligible y el desarrollo de un lenguaje coherente, fluido y expresivo”. Rodríguez Xiomara, 2012

Estructura del tratamiento

Introducción: Establecimiento de una comunicación favorable entre logopeda y educandos a partir de una adecuada motivación que debe establecer el tema a tratar, así como la orientación del objetivo y creación de condiciones previas.

Desarrollo: en esta parte del tratamiento el diseño de las actividades se debe corresponder con la línea general para cada una de las patologías según las prioridades por etapa de trabajo.

Tarea: debe ser antes de las conclusiones, pueden orientarse en diferentes momentos atendiendo a la edad grado y particularidades del desarrollo en general del educando/a, además hay que tener en cuenta que incluya todos los objetivos tratados en la actividad. El educando/a debe quedar bien orientado sobre qué trata la tarea y cómo desarrollarla.

Conclusión: Se establecerá una conversación final donde los educandos deben responder preguntas sobre el tratamiento, llegando si es posible a dar el significado que se trabajó en la palabra del vocabulario

Sistema de tratamientos

Tratamiento 1

Eje temático: Los animales

Objetivo: Identificar los nombres de los animales.

Método: conversación

Procedimiento: observación, preguntas y respuestas

Material verbal: perro, gato, gallo, vaca

Medios de enseñanza: espejo, lámina, tarjeta por imágenes, colores, rompecabezas

Forma de evaluación: individual

Introducción

Buenos días, como te sientes, que hiciste en la casa, celebrar los logros

Motivación: Le muestro una lámina sobre los animales y le pregunto que está viendo, que son, si los conoce, los nombres

Oriento el objetivo: Buenos como vimos en la lámina en el día de hoy vamos a identificar los nombres de los animales

Desarrollo

Act 1 Realizar los ejercicios prearticulatorios frente al espejo

Act 2 Le presento cinco tarjetas de animales en un orden, ella debe memorizarlas y ordenarlas por el orden en que estaban

Act 3 Escribe los nombres de los animales en letra cursiva en una hoja

Act 4 Realiza el siguiente rompecabezas

Act 5 Ahora vamos a jugar a las adivinanzas, yo te la digo y tú responde

Canto en la orilla, vivo en el agua, no soy pescado, ni soy cigarra ¿Quién soy? La rana
Soy astuto y juguetón y cazar un ratón es mi afición ¿Quién soy?

Conclusiones

¿Qué trabajamos hoy? te gusto la actividad, que fue lo que más te gusto, a ver, realiza un dibujo donde aparezcan tres de los animales estudiados hoy.

Tarea

1 Realiza frente al espejo los ejercicios prearticulatorio con ayuda de mamá.

2 Realiza un dibujo sobre los animales que vemos en el zoológico.

Tratamiento 2

Eje temático: Visita al zoológico

Objetivo: Identificar los animales que hay en el zoológico

Método: observación

Procedimiento: descripción, preguntas y respuestas

Material verbal: león, tigre, mono, cebra

Medios de enseñanza: objetos reales, tarjetas por imágenes, colores

Forma de evaluación: individual

Introducción

Buenos días, como te sientes, que hiciste en la casa, celebrar los logros

Oriento el objetivo: Como estamos viendo hoy estamos en el zoológico y el objetivo del día de hoy es identificar los animales que hay aquí en el zoológico

Motivación: visita al zoológico

Desarrollo

Act 1 Realizar un recorrido por el zoológico para observar los animales

Act 2 Realizar los sonidos onomatopéyicos de cada animal visto

Act 3 Nos sentamos en un parque y le muestro algunas tarjetas, ella tiene que seleccionar las tarjetas de los animales que ha visto y describirlos

Act 4 Pintarnos la cara del animal que más nos gusto

Conclusiones

¿Te gustó la visita a este lugar?

¿Qué fue lo que más te gustó?

¿Qué trabajamos hoy y cómo crees que trabajaste?

Tarea

Realiza un dibujo sobre lo que viste en la visita al zoológico

Tratamiento 3

Eje temático: Los animales del zoológico

Objetivo: Nombrar los animales del zoológico

Método: conversación

Procedimiento: lenguaje conjunto, preguntas y respuestas

Material verbal: león, elefante, jirafa

Medios de enseñanza: espejo, material audiovisual

Forma de evaluación: individual

Introducción

Buenos días, como te sientes, que hiciste en la casa, celebrar los logros

Oriento el objetivo: Bueno en el día de hoy vamos a nombrar los animales del zoológico

Motivación: Se le muestra un video musical sobre animales en el zoológico

Desarrollo

Act 1 Realizar ejercicios prearticulatorios frente al espejo

Act 2 Nombra todos los animales que aparecen en el video

Act 3 Enlaza el animal con su color

Caballo	amarillo
---------	----------

Elefante	verde
----------	-------

Jirafa	gris
--------	------

Cocodrilo	carmelita
-----------	-----------

Act 4 Escribe cinco nombres de animales que aparecen en la canción

Act 5 Escribe un fragmento de la canción y léelo

Conclusiones

¿Que trabajamos hoy y cómo crees que trabajaste?

¿Te gusto el tema que trabajamos hoy?

Realiza 2 oraciones con los animales que más te gustaron

Tarea

Ejercitar la escritura en letra cursiva

Memoriza para el próximo tratamiento una canción que se relacione con un animal marino

Tratamiento 4

Eje temático: Los animales marinos

Objetivo: Reconocer los animales marinos.

Método: explicación

Procedimiento: preguntas y respuestas

Material verbal: pez, caballo de mar, ballena

Medios de enseñanza: espejo, tarjetas por imágenes, rompecabezas

Forma de evaluación: individual

Introducción

Buenos días, como te sientes, que hiciste en la casa, celebrar los logros

Oriento el objetivo: Bueno en el día de hoy vamos a reconocer los animales marinos

Motivación: Con anterioridad se le había escondido en el gabinete algunas tarjetas a modo de tesoro escondido, las cuales la niña debe encontrar, son 5 tarjetas.

Desarrollo

Act 1 Realizar los ejercicios prearticulatorios frente al espejo

Act 2 Observa las siguientes tarjetas por unos minutos

Cual se encuentra arriba de la ballena

Cual se encuentra a la derecha del caballo de mar

Cual está debajo del delfín

Cual está a la izquierda de la estrella de mar

Act 3 Ahora vamos a armar este rompecabezas, luego lo memorizar y realiza un cuento relacionado con la imagen descubierta

Act 4 Lee las siguientes oraciones

Los peces viven felices en el mar.

Me encantaría una visita al acuario

Conclusiones

¿Que trabajamos hoy y cómo crees que trabajaste?

¿Te gusto el tema que trabajamos hoy?

Cuáles fueron los animales estudiados hoy y en que muñequitos podemos verlos

Tarea

Practicar la lectura en el hogar con ayuda de mama

Realiza 3 oraciones con los animales estudiados hoy

Tratamiento 5

Eje temático: Visita al Acuario

Objetivo: Identificar los animales del acuario

Método: conversación

Procedimiento: lenguaje espontaneo, preguntas y respuestas

Material verbal: pez, delfín, foca, tiburón

Medios de enseñanza: objetos reales, plastilina, colores

Forma de evaluación: individual

Introducción

Buenos días, como te sientes, que hiciste en la casa, celebrar los logros

Oriento el objetivo: Como vemos estamos en el acuario y hoy vamos a identificar los animales del acuario

Motivación: Visita al acuario

Desarrollo

Act 1 Recorrido por el acuario para ver todos los animales

Act 2 Vamos a pintarnos la cara del animal que más nos gusto

Act 3 Realiza con la plastilina 5 de los animales que viste en el recorrido

Act 4 Realiza un dibujo de uno de los animales en su habitat natural

Conclusiones

¿Qué trabajamos hoy y cómo crees que trabajaste?

¿Te gusto el tema que trabajamos hoy?

Tareas

Realizar los ejercicios prearticulatorios frente al espejo en el hogar

Investiga cuales son las partes del cuerpo del pez

Tratamiento 6

Eje temático: Las partes del cuerpo

Objetivo: Pronunciar palabras con el fonema /r/ en la posición media

Método: conversación

Procedimiento: pronunciación enfatizada

Material verbal: cuerpo, nariz, pierna, brazo, oreja

Medios de enseñanza: tarjeta por imágenes, espejo, tarjetas para recortar, goma de pegar, hoja de trabajo.

Forma de evaluación: individual.

Introducción

Buenos días, como te sientes, que hiciste en la casa, celebrar los logros

Oriento el objetivo: Bueno en el día de hoy vamos a pronunciar palabras con el fonema /r/ en la posición media

Motivación: Le presento una lámina sobre el cuerpo humano, le pregunto que ve, que describa lo que está en la lámina y que es todo en general.

Desarrollo

Act 1 Realizar los ejercicios prearticulatorios frente al espejo

Act 2 Revisión de la tarea del tratamiento anterior sobre las partes del cuerpo del pez y le explico brevemente que los humanos también tenemos partes del cuerpo. Le pregunto cuáles son las partes de su cuerpo.

Act 3 Pronuncia las siguientes palabras

nariz, cara, pierna, oreja, brazo, boca, ojos, dientes

Act 4 Recorta las figuras de las tarjetas y pégalas en orden en una hoja formando el cuerpo humano.

Act 5 Escribe en la hoja de trabajo las partes de tu cuerpo.

Conclusiones

¿Que trabajamos hoy y cómo crees que trabajaste?

¿Te gusto el tema que trabajamos hoy?

Ahora vamos a señalar las partes del cuerpo que aprendiste hoy

Tarea

Realizar ejercicios prearticulatorios frente al espejo con ayuda de mamá.

Traer para el próximo tratamiento un dibujo de tu cuerpo.

Tratamiento 7

Eje temático: Las partes del cuerpo.

Objetivo: Pronunciar el fonema /r/ en oraciones.

Método: conversación

Procedimiento: pronunciación enfatizada, observación

Material verbal: cara, nariz, oreja, pierna.

Medios de enseñanza: componedor, espejo, rotulo, tarjetas por imágenes

Forma de evaluación: individual.

Introducción

Buenos días, como te sientes, que hiciste en la casa, celebrar los logros

Oriento el objetivo: En el día de hoy vamos a pronunciar el fonema /r/ en oraciones

Motivación: Vamos a realizar un juego didáctico llamado “Tocando mi cuerpo” consiste en que yo voy a decir una parte del cuerpo y tú tienes q señalarlo en el menor tiempo posible

Desarrollo

Act 1 Lee las siguientes oraciones y escríbelas en el componedor

Mi cuerpo es hermoso

Yo me lavo la cara siempre

Mis brazos y piernas son fuertes

Act 2 Realiza los ejercicios prearticulatorios frente al espejo

Act 3 Enlaza la tarjeta de la parte del cuerpo con la oración que aparece en los rótulos

Act 4 Dictado de oraciones donde aparezcan palabras con el fonema /r/

Me duele una pierna

Tenemos que tener las orejas limpias

Act 5 Realiza el análisis fónico de estas palabras

pierna

orejas

Conclusiones

¿Que trabajamos hoy y cómo crees que trabajaste?

¿Te gustó el tema que trabajamos hoy?

Menciona las partes del cuerpo que en su nombre aparezca el fonema /r/

Tarea

Investiga que acciones se pueden realizar con las partes del cuerpo.

Tratamiento 8

Eje temático: Acciones

Objetivo: Pronunciar el fonema /r/ en diferentes posiciones, en distintas situaciones problemáticas.

Método: conversación

Procedimiento: observación, pronunciación enfatizada, preguntas y respuestas

Material verbal: jugar, correr, limpiar

Medios de enseñanza: espejo, tarjetas de acciones

Forma de evaluación: individual

Introducción

Buenos días, como te sientes, que hiciste en la casa, celebrar los logros

Oriento el objetivo: En el día de hoy vamos a pronunciar el fonema /r/ en diferentes posiciones en distintas situaciones

Motivación: Vamos a cantar una canción, la canción se llama, dramatiza cada acción

Desarrollo

Act 1 Realiza los ejercicios prearticulatorios frente al espejo

Act 2 Revisión de la tarea del tratamiento anterior, que acciones podemos hacer con las partes del cuerpo, realiza el gesto

Act 3 Le presento algunas tarjetas y tiene que nombrarla y que colores tiene

Act 4 Le presento las tarjetas para realizar la técnica del cuarto excluido, le presento 3 tarjetas de acciones y 1 de una fruta y ella tiene que señalar cual no pertenece al conjunto, así con 3 tarjetas de acciones y 1 de un animal

Act 5 Lee el siguiente párrafo

Por la mañana me despierto y me lavo los dientes. Luego mi mamá me prepara un sabroso desayuno, me pongo el uniforme y me voy para la escuela. Cuando llego saludo a la maestra, estudio, meriendo, juego con mis compañeros y aprendo muchas cosas interesantes.

¿Qué fue lo primero que hice?

¿Qué fue lo que hice antes de ponerme el uniforme?

¿Qué hice cuando llegue a la escuela?

Conclusiones

¿Que trabajamos hoy y cómo crees que trabajaste?

¿Te gusto el tema que trabajamos hoy?

¿Qué acciones tú haces en tu casa?

Tratamiento 9

Eje temático: Las acciones en el hogar

Objetivo: Pronunciar el fonema /r/ en diferentes posiciones.

Método: conversación

Procedimiento: observación, pronunciación enfatizada, preguntas y respuestas

Material verbal: comer, bañarse, limpiar, peinarse

Medios de enseñanza: espejo, tarjetas de acciones, colores, material audiovisual

Forma de evaluación: individual

Introducción

Buenos días, como te sientes, que hiciste en la casa, celebrar los logros

Oriento el objetivo: En el día de hoy vamos a pronunciar el fonema /r/ en diferentes posiciones

Motivación: Se presenta un video donde sale un educando realizando acciones al llegar a su casa

Desarrollo

Act 1 Realizar los ejercicios prearticulatorios frente al espejo

Act 2 Nombrar cada una de las acciones vistas en el video y decir en que horario se realizan, cual te gusta más y cual no te gusta

Act 3 Le enseño ocho tarjetas y debe memorizarlas hasta que se las quite, luego debe decir cual falta, así varias veces

Act 4 Le presento cuatro tarjetas y debe realizar la misma cantidad de oraciones con cada acción que vio en la tarjeta y escribirla en el cuaderno de trabajo

Act 5 Realiza un dibujo tuyo realizando alguna acción

Conclusiones

¿Que trabajamos hoy y cómo crees que trabajaste?

¿Te gusto el tema que trabajamos hoy?

Tarea

Realizar los ejercicios prearticulatorios frente al espejo con ayuda de mamá

Tratamiento 10

Eje temático: Las acciones en el hogar

Objetivo: Pronunciar el fonema /r/ en diferentes posiciones

Método: conversación

Procedimiento: observación, pronunciación enfatizada, preguntas y respuestas

Material verbal: comer, bañarse, limpiar, peinarse

Medios de enseñanza: tarjeta por secuencia e imágenes, cuaderno de trabajo

Forma de evaluación: individual

Introducción

Buenos días, como te sientes, que hiciste en la casa, celebrar los logros

Oriento el objetivo: En el día de hoy vamos a pronunciar el fonema /r/ en diferentes posiciones

Motivación: Vamos a realizar un recorrido por la escuela para ver qué acciones vemos y nombrarlas

Desarrollo

Act 1 Le presento 5 tarjetas y tiene que decir su nombre y si está arriba, abajo, derecha o izquierda

Act 2 Lee las siguientes palabras y divídelas en sílabas

Lavar, comer, orinar, bañarse, jugar, beber, merendar, bailar, peinarse

Act 3 Escribe las palabras anteriores en el cuaderno de trabajo

Act 4 Organizar las tarjetas por el orden de secuencia de lo que debe realizar la niña al llegar de la escuela

Act 5 Asocia una parte del cuerpo con las tarjetas de las acciones

Conclusiones

¿Que trabajamos hoy y cómo crees que trabajaste?

¿Te gusto el tema que trabajamos hoy?

Tarea

Ejercitar la lectura y la escritura

Se le realizó el cuestionario para la valoración cualitativa del estudio de caso a los directivos de la escuela especial Lazo de la Vega donde obtuve los resultados entre bastante adecuado (BD) y muy adecuado (MA).

CONCLUSIONES

Los fundamentos teóricos y metodológicos constituyeron un factor fundamental para realizar este trabajo, aportando cada conocimiento para lograr un entendimiento claro

del objetivo y a su vez de cada contenido, como lo es el estudio de caso, el trastorno del espectro autista y el retraso simple del lenguaje. El estudio de caso permitió indagar sobre el entorno escolar y familiar, sobre las dificultades que conlleva presentar un trastorno del espectro autista y también características propias de este trastorno, de las cuales una de las más evidentes es la que dificultan la comunicación expresiva.

El educando al que se le realizó el estudio de caso presenta un trastorno del espectro autista, lo que dio lugar a la falta de comunicación. Posee un trastorno de la comunicación del nivel lenguaje enmarcado en un retraso simple del lenguaje caracterizado por una tardía aparición del lenguaje y no acorde con su edad cronológica; dificultad en la pronunciación de varios fonemas y en el lenguaje activo.

La estrategia de intervención planteada está acorde con las necesidades identificadas durante los métodos y técnicas utilizadas, incitando así, a que la escuela y el hogar sean parte del cumplimiento de la misma para un satisfactorio avance del educando. El sistema de tratamiento es de fácil comprensión y aplicación.

RECOMENDACIONES

Aplicar el sistema de tratamientos logopédicos al educando objeto de estudio.

Orientar a la familia para una mejor comunicación entre el educando y la comunidad.

Priorizar el enriquecimiento del vocabulario activo y pasivo.

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ C. Diagnóstico y Diversidad. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación; 2009.

Andrés. J. El diseño de caso único en investigación en psicología clínica. Un vínculo entre la investigación y la práctica clínica. Revista Argentina de Clínica Psicológica, vol. XVI. Num.3.nov, 2007.

Best. J. Como investigar en Educación. Ediciones Morata, S. A. (1982) Capitulo V.

CÁRDENAS C, PRADO R, MÉNDEZ I, MARTÍN M. Manual de juegos y ejercicios para el tratamiento logopédico. La Habana, Cuba: Editorial de Libros para la Educación; 1980.

CÁRDENAS C, FIGUEREDO E, MARTÍN M, PRATS E, RODRÍGUEZ O, LLANES T, ET AL. Glosario de terminología logopédica. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación; 1976.

Díaz, S. A., Mendoza, V., y Porras, C. Una guía para la elaboración de estudios de caso. RAZÓN Y PALABRA .2011. Obtenido de www.razonypalabra.org.mx.

Dubé Y. Estudio de caso. La Habana, Cuba: Facultad de Educación Infantil, Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”.2011.

FERNÁNDEZ I L, VÁZQUEZ G. Recursos tecnológicos para el tratamiento logopédico. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación; 2008.

Figueredo E, López M. Logopedia I. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.1984.

Figueredo E, López M. Logopedia II. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.1986.

Garrido. J. Programación de actividades para la educación especial. C.E.P.E., Madrid.1993

Gómez Tolón, J. Trastornos de la adquisición del lenguaje. Escuela Española, Madrid.1987.

HERNÁNDEZ, Y. Estudio de caso. La Habana, Cuba: Facultad de Educación Infantil, Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”; 2011.

Nieto, M. Retardo del lenguaje. C.E.P.E., Madrid.1990.

Nieves Rivero, M, L. El diagnóstico en la escuela primaria. Documentos de trabajo metodológico en el CDO. Santiago de Cuba. 2001.

Pérez, G. Investigación Cualitativa. Retos e interrogantes. Fotocopia. Capitulo III.1996.

ANEXOS

Anexo 1 Guía de observación

Hora de llegada del menor a la escuela

Actitud y estado de ánimo en la mañana

¿Con cuántos compañeros se relaciona durante todo el día?

A la hora del juego ¿cómo participa?

Limpieza durante la hora de merienda y del almuerzo

Comportamiento durante la hora del sueño

En las actividades programadas:

- Actitud en cada una de ellas
- ¿Cuál le simpatiza más?
- ¿Cuál le interesa menos?
- ¿En cuál tiene más dificultades
- Niveles de ayuda que necesita para realizar una tarea
- Tiempo de demora para cada orientación
- Calidad de los resultados obtenidos en la tarea.
- Nivel de participación

Anexo 2 Guía de entrevista a la maestra

Se solicita una entrevista para conocer su criterio respecto al educando CIGG en la escuela y a su familia, gracias de antemano por la cooperación

Preguntas:

- 1- Tiempo trabajando con el educando
- 2- Evolución desde que trabaja con el educando
- 3- Relación hogar-escuela
- 4- Actitud del educando ante las dificultades
- 5- Comportamiento en el aula

Acciones que contribuyan al desarrollo del educando

Anexo 3 Guía de entrevista a la familia. Datos que favorecen o dificultan el desarrollo del educando

Estructura familiar:

- Composición del núcleo familiar
- Relación con la familia extendida
- Actividades profesionales o académicas de los distintos miembros de la familia

Relaciones familiares:

- Estructura jerárquica
- Relaciones que se establecen con el educando: dedicación y reparto de roles-afinidades y rechazos
- Normas fundamentales para el educando

Valores:

- Actitudes, expectativas, reparto de tareas respecto a los distintos sexos
- Preocupación por la salud, hábitos saludables, etcétera
- Actitud hacia el consumo
- Valoración de las relaciones sociales fuera del contexto familiar
- Implicación en la vida cotidiana
- Importancia que se le da a los estudios y a los distintos contenidos curriculares

Actitud ante las dificultades del educando:

- Aspectos que más les preocupan a la evolución del educando
- Influencia en la dinámica y relaciones familiares

Calidad de la comunicación de los padres (y hermanos) con el educando

Anexo 4: Cuestionario para la valoración cualitativa del estudio de caso

Estimado(a) directivo

Se necesita su criterio respecto a la información registrada en el estudio de caso realizado al educando -----, por la estudiante de 4to año -----, de la carrera Licenciatura en Educación Logopedia. La valoración que usted ofrezca resultará de gran valía para el perfeccionamiento en la atención educativa en general y logopédica en particular. Se agradece anticipadamente su apreciable cooperación.

Objetivo: Valorar cualitativamente el estudio de caso (EC) realizado al educando.....

Datos generales

Lugar en que labora: _____

Graduado(a) de: _____

Años de experiencia en la labor docente: _____

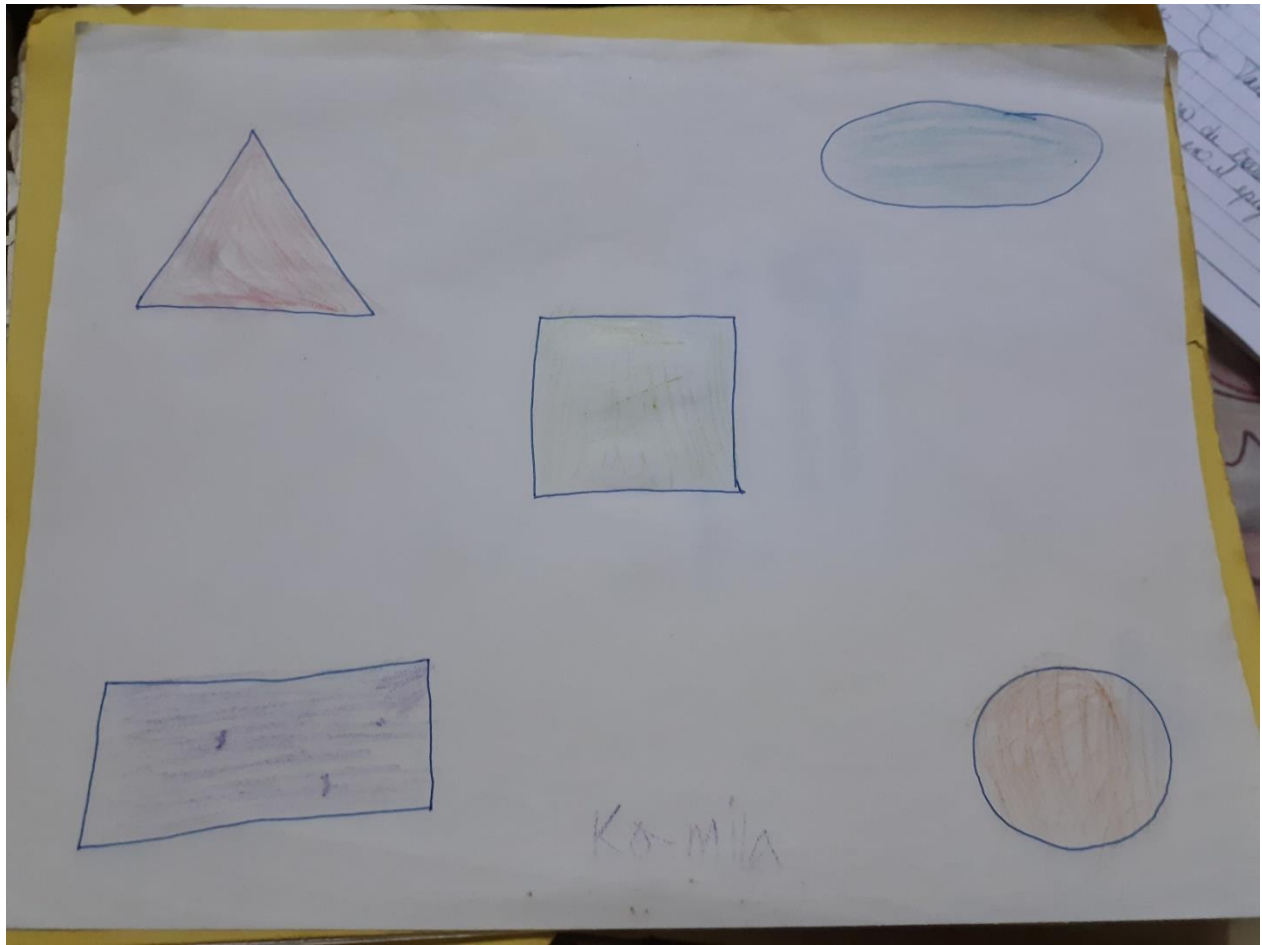
Experiencia en la labor de dirección: _____

Para la valoración de cada indicador utilice la escala: inadecuado (I), poco adecuado (PA), adecuado (A), bastante adecuado (BA) y muy adecuado (MA)

#	Indicadores	I	PA	A	BA	MA
1	Nivel de correspondencia entre el objetivo del EC y sus resultados generales					
2	Utilidad de la información registrada en el informe del EC para la labor logopédica					
3	Estructura y contenido del informe de EC					
4	Correlación entre las tareas planificadas en la estrategia de atención logopédica y las necesidades descritas en el educando					

Sugerencias que ofrece al estudiante

Anexo 5: Técnica del dibujo libre



KAMILA

sofia



